

Descripción de lesiones elementales: mácula, pápula, vesícula, pústula, placa, úlcera

1. Introducción y relevancia clínica

La **semiología dermatológica** constituye el **lenguaje fundamental** para describir, clasificar y diagnosticar las enfermedades cutáneas.

En dermatología, el diagnóstico se basa **principalmente en la observación clínica**, por lo que la correcta **identificación de las lesiones elementales** —sus características, distribución y evolución— es tan relevante como un examen físico en cualquier otra especialidad.

El conocimiento y dominio del **vocabulario dermatológico** permite:

- Precisar la naturaleza y profundidad de la lesión (epidérmica, dérmica o subcutánea).
- Orientar la etiología (inflamatoria, infecciosa, alérgica, neoplásica, etc.).
- Facilitar la comunicación clínica y la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas.

En el examen **EUNACOM**, las descripciones morfológicas clásicas de lesiones (p. ej., “mácula hiperpigmentada de bordes netos”, “vesículas agrupadas sobre base eritematosa”) son **preguntas frecuentes**, por lo que dominar esta clasificación es esencial.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Las **lesiones elementales** representan **alteraciones morfológicas visibles o palpables** de la piel, y se dividen en **primarias** (manifestación inicial del proceso patológico) y **secundarias** (cambios evolutivos o resultantes del rascado, infección o tratamiento).

2.1. Clasificación general

Tipo de lesión	Definición general	Ejemplo clásico

Primarias	Resultado directo del proceso patológico inicial	Mácula, pápula, vesícula, pústula, placa, nódulo, habón
Secundarias	Resultan de la evolución o manipulación de lesiones primarias	Escama, costra, erosión, úlcera, fisura, cicatriz, liquenificación

El reconocimiento correcto depende de comprender la **anatomía de la piel** (tema anterior): las lesiones epidérmicas suelen ser **planas o superficiales**, mientras que las dérmicas o hipodérmicas son **elevadas o profundas**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

A continuación, se describen las **lesiones elementales más relevantes para la práctica clínica y el examen EUNACOM**, con su definición, características, profundidad, ejemplos y diagnósticos diferenciales.

3.1. Mácula

Definición:

Lesión **plana, no palpable**, de **coloración diferente** a la piel normal, sin cambios de espesor ni consistencia.

Fisiopatología:

Alteración en la pigmentación (melanina), vascularización o depósito de sustancias exógenas o endógenas.

Clasificación según color:

Tipo de mácula	Mecanismo	Ejemplo
Eritematosa	Vasodilatación reversible	Exantemas virales, dermatitis

Purpúrica	Extravasación de sangre (no desaparece a la vitropresión)	Petequias, púrpura trombocitopénica
Pigmentaria	Alteración de melanina (aumento o disminución)	Nevus, vitiligo, melasma
Exógena	Depósito de pigmentos externos	Tatuajes, impregnación por metales

Ejemplos clínicos:

- Máculas hiperpigmentadas en melasma.
- Máculas hipocrómicas en vitiligo.
- Máculas eritematosas en sarampión o rubéola.

Diagnóstico diferencial:

Eritema vs petequia (vitropresión positiva en eritema; negativa en petequia).

3.2. Pápula

Definición:

Lesión **sólida**, **elevada**, **menor de 1 cm** de diámetro, **superficial** (epidérmica o dérmica superior).

Fisiopatología:

Infiltrado inflamatorio localizado, hiperplasia epidérmica o depósito local (por ejemplo, grasa, queratina).

Ejemplos clínicos:

- Pápulas eritematosas pruriginosas en dermatitis atópica.
- Pápulas firmes en liquen plano o sífilis secundaria.
- Pápulas perladas del pene (fisiológicas).

Diagnóstico diferencial:

Pápula vs vesícula (sólida vs con contenido líquido).

Pápula vs nódulo (superficial vs profundo).

3.3. Vesícula

Definición:

Lesión **elevada**, de **contenido líquido claro**, **menor de 1 cm** de diámetro.

Fisiopatología:

Acúmulo de líquido seroso entre capas epidérmicas (espongiosis, necrosis o degeneración vacuolar).

Ejemplos clínicos:

- Vesículas agrupadas sobre base eritematosa en **herpes simple**.
- Vesículas diseminadas en **varicela**.
- Vesículas interdigitales en **dermatitis por contacto o dishidrosis**.

Diagnóstico diferencial:

- **Vesícula <1 cm, ampolla >1 cm.**
 - Si el contenido es purulento → **pústula**.
-

3.4. Pústula

Definición:

Lesión **elevada**, **con contenido purulento (leucocitos, detritos celulares)**, de tamaño variable.

Fisiopatología:

Resultado de una infección bacteriana, inflamación folicular o respuesta inmune neutrofílica.

Ejemplos clínicos:

- **Foliculitis bacteriana** (pústula centrada en un pelo).
- **Acné vulgar** (pápulo-pústulas en cara y tronco).
- **Pustulosis palmoplantar** (psoriasis pustulosa localizada).

Diagnóstico diferencial:

Pústula vs vesícula → contenido turbio (pus) vs seroso.

Pústula vs absceso → tamaño pequeño y superficial vs colección profunda.

3.5. Placa

Definición:

Lesión **elevada, plana**, de **más de 1 cm** de diámetro, que puede resultar de la **confluencia de pápulas**.

Fisiopatología:

Engrosamiento epidérmico o infiltración dérmica superficial.

La superficie puede ser lisa, rugosa o descamativa.

Ejemplos clínicos:

- **Psoriasis vulgar**: placas eritematoescamosas en codos y rodillas.
- **Liquen plano**: placas violáceas y pruriginosas.
- **Micosis fungoide (linfoma cutáneo)**: placas infiltradas.

Diagnóstico diferencial:

Placa vs nódulo → la primera es superficial y extendida; el segundo es más profundo y localizado.

3.6. Úlcera

Definición:

Pérdida **total de la continuidad de la piel**, comprometiendo epidermis y dermis, con exposición de tejido subyacente.

Fisiopatología:

Necrosis tisular secundaria a isquemia, infección, presión, trauma o inflamación crónica.

Ejemplos clínicos:

- **Úlcera varicosa:** en maléolos internos, con bordes irregulares y fondo fibrinoso.
- **Úlcera arterial:** dolorosa, de bordes netos, en zonas distales.
- **Úlcera por decúbito:** en prominencias óseas por presión prolongada.
- **Úlcera infecciosa:** p. ej., leishmaniasis cutánea o pioderma gangrenoso.

Diagnóstico diferencial:

Úlcera vs erosión → la erosión solo afecta epidermis (no deja cicatriz).

3.7. Otras lesiones elementales relevantes (de repaso rápido)

Lesión	Definición	Ejemplo clínico
Nódulo	Lesión sólida, >1 cm, profunda, palpable	Lipoma, eritema nodoso
Ampolla (flictena)	Lesión líquida >1 cm	Quemaduras, pénfigo
Costra	Producto de la desecación de exudado o sangre	Impétigo
Escama	Acúmulo de queratina descamante	Psoriasis, pitiriasis versicolor
Fisura	Grieta lineal dolorosa	Queilitis angular
Cicatriz	Sustitución por tejido fibroso	Postacné, cirugía

Liquenificación	Engrosamiento cutáneo por rascado crónico	Eccema crónico
------------------------	---	----------------

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de las lesiones elementales es principalmente **clínico**. Sin embargo, en algunos casos se requieren exámenes para confirmar etiología o profundidad.

Examen	Indicación	Interpretación
Dermatoscopía	Evaluar lesiones pigmentarias o vasculares	Patrón de pigmento, red reticular, vasos atípicos
Biopsia cutánea	Lesiones atípicas, persistentes o neoplásicas	Histología confirma diagnóstico
Tinción de Gram / Giemsa	Lesiones pustulosas o ulceradas	Identificación bacteriana o parasitaria
Raspado con KOH	Lesiones escamosas o vesiculares	Confirma tiña o candida
Vitropresión (diascopia)	Diferencia eritema vs púrpura	Desaparece o no con presión

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento depende de la **lesión y su causa**, pero existen principios generales de manejo cutáneo:

5.1. Cuidados básicos

- **Higiene suave:** evitar jabones alcalinos o abrasivos.
- **Evitar rascado:** uso de guantes, hidratación intensiva, manejo del prurito.
- **Emolientes:** restauran la barrera cutánea.
- **Fotoprotección:** FPS ≥ 30 .

5.2. Tratamiento específico según tipo de lesión

Lesión	Abordaje general
Máculas pigmentarias	Despigmentantes tópicos (hidroquinona, ácido kójico), fotoprotección estricta.
Pápulas y pústulas (acné, foliculitis)	Antibióticos tópicos/orales, retinoides, peróxido de benzoilo.
Vesículas (herpes, varicela)	Antivirales tópicos o sistémicos según severidad (aciclovir).
Placas inflamatorias (psoriasis, eczema)	Corticoides tópicos, inhibidores de calcineurina, fototerapia.
Úlceras cutáneas	Curaciones estériles, desbridamiento, control de causa (venosa, arterial, presión).

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- **Infección secundaria** (impetiginización) por rascado.
- **Cicatrices o hiperpigmentación postinflamatoria.**

- **Cronificación o liquenificación** en dermatitis.
- **Úlceras crónicas** con riesgo de transformación neoplásica (Marjolin).

Pronóstico

Depende de la causa subyacente.

Las lesiones primarias benignas suelen tener **pronóstico excelente**, mientras que las ulceradas o infiltradas requieren estudio histológico y control especializado.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. La **pápula** es sólida y <1 cm; el **nódulo** es sólido y >1 cm.
2. La **vesícula** contiene líquido seroso; la **pústula**, líquido purulento.
3. Las **máculas purpúricas** no desaparecen con la vitropresión.
4. En **psoriasis**, la lesión típica es una **placa eritematosa con escama plateada**.
5. Las **vesículas agrupadas en racimos sobre base eritematosa** son casi patognomónicas de **herpes simple**.
6. **Toda úlcera crónica no cicatrizante debe biopsiarse**.
7. En niños, las **lesiones papulosas con costra melicérica** son típicas de **impétigo**.



Errores comunes

- Confundir **mácula eritematosa** con **petequia** sin realizar vitropresión.
- Describir como “heridas” lesiones inflamatorias (error terminológico frecuente).
- No diferenciar **vesícula vs pústula** (líquido claro vs purulento).

- Omitir la **localización anatómica y patrón de distribución** (clave diagnóstica).
 - Tratar sin diagnóstico morfológico previo (uso empírico de corticoides tópicos).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **lesiones elementales** son la base de la semiología dermatológica; pueden ser **primarias o secundarias**.
2. La **mácula** es plana; la **pápula** y **placa** son sólidas; la **vesícula** y **pústula** contienen líquido.
3. La **úlcer**a implica pérdida completa de la piel; siempre debe evaluarse su causa (vascular, infecciosa o neoplásica).
4. La **vitropresión** distingue lesiones vasculares (desaparecen) de hemorrágicas (persisten).
5. **El reconocimiento morfológico preciso** orienta el diagnóstico y el manejo dermatológico adecuado.
6. La **fotoprotección, higiene y emoliencia** son pilares del tratamiento transversal.
7. En EUNACOM, describir con precisión **color, forma, tamaño, contenido y distribución** es determinante para la respuesta correcta.